

Manejo del Síndrome de Abstinencia

1. Introducción y relevancia clínica

El **síndrome de abstinencia** (SA) corresponde al conjunto de **síntomas físicos y psicológicos** que aparecen tras la **suspensión o reducción brusca** de una sustancia psicoactiva consumida de manera prolongada.

Refleja la **dependencia fisiológica** que el cuerpo ha desarrollado, y su intensidad depende de:

- La **sustancia específica** (alcohol, benzodiazepinas, opioides, estimulantes, cannabis).
- La **dosis y duración** del consumo.
- La **vulnerabilidad individual** (edad, comorbilidad médica y psiquiátrica).

Es una **condición médica potencialmente grave**, particularmente en el caso del **alcohol y las benzodiazepinas**, donde puede ser **letal si no se maneja adecuadamente**.

□ En el **EUNACOM**, este tema se evalúa a menudo en escenarios de urgencia: un paciente hospitalizado por otra causa presenta **temblores, agitación o convulsiones**, o un **adicto a opiáceos con síntomas vegetativos intensos** tras suspensión del consumo.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Mecanismo general

El uso repetido de una droga altera la homeostasis neuroquímica del cerebro.

Durante el consumo crónico, los sistemas neurotransmisores se **adaptan** a la presencia del fármaco:

- **Alcohol y benzodiazepinas:** estimulan el sistema **GABAérgico (inhibitorio)** y suprimen el **glutamatérgico (excitatorio)**.
- **Opiáceos:** inhiben la liberación de GABA en la vía dopaminérgica mesolímbica.
- **Estimulantes (cocaína, anfetaminas):** aumentan dopamina y noradrenalina sin control.

- **Cannabis:** activa receptores cannabinoides (CB1) modulando dopamina y GABA.

Cuando el consumo se detiene bruscamente:

- Disminuye la neurotransmisión inhibitoria y **predomina la excitación neuronal.**
- Esto causa los síntomas característicos: ansiedad, temblores, taquicardia, insomnio, convulsiones, etc.

2.2. Bases fisiológicas por tipo de sustancia

Sustancia	Neurotransmisor afectado	Efecto del consumo crónico	Efecto del retiro
Alcohol	GABA ↑, Glutamato ↓	Depresión SNC	Hiperexcitabilidad, convulsiones
Benzodiacepinas	GABA ↑	Depresión SNC	Ansiedad, convulsiones
Opiáceos	Dopamina ↑, GABA ↓	Analgesia, euforia	Dolor, disforia, síntomas vegetativos
Cocaína / anfetaminas	Dopamina ↑	Estimulación	Fatiga, depresión, anhedonia
Cannabis	CB1 ↑	Modulación dopaminérgica	Irritabilidad, insomnio, disforia

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

Cada sustancia produce un cuadro clínico distinto en su síndrome de abstinencia.

Los siguientes son los más relevantes para la práctica médica y el EUNACOM:

3.1. Abstinencia alcohólica

Inicio: 6–24 horas después de la última ingesta.

Duración: 3–7 días.

Síntomas leves: ansiedad, insomnio, náuseas, temblor fino, taquicardia.

Síntomas severos:

- Convulsiones tónico-clónicas generalizadas (12–48 h).
- Alucinaciones visuales (zoopsias).
- **Delirium tremens:** confusión, agitación, fiebre, hipertensión y riesgo vital.

☐ Emergencia médica: **Delirium tremens** → **UCI + benzodiacepinas EV.**

3.2. Abstinencia a benzodiacepinas

Inicio: depende de la vida media del fármaco.

- Corta (alprazolam): 6–12 h.
- Larga (diazepam): 2–7 días.

Síntomas: ansiedad, insomnio, irritabilidad, temblores, náuseas, convulsiones, delirium.

Puede durar **semanas a meses**.

☐ Riesgo letal si la suspensión es brusca tras uso prolongado (>4 semanas).

3.3. Abstinencia a opiáceos (heroína, morfina, metadona)

Inicio:

- Heroína: 8–12 h tras última dosis.
- Metadona: 24–36 h.

Síntomas característicos:

- Rinorrea, lagrimeo, piloerección (“piel de gallina”).
- Dolores musculares, bostezos, fiebre baja.
- Náuseas, vómitos, diarrea, insomnio.
- Pupilas dilatadas, ansiedad, craving intenso.

Aunque **no es letal**, es muy incómodo y requiere manejo sintomático y contención.

3.4. Abstinencia a cocaína y estimulantes

Inicio: horas después de la suspensión.

Duración: días a semanas.

Síntomas:

- Fatiga intensa, hipersomnia, depresión marcada.
- Irritabilidad, anhedonia, craving intenso.
- Ideación suicida.

No hay síntomas físicos graves, pero el **riesgo suicida** es alto en esta fase.

3.5. Abstinencia a cannabis

Inicio: 24–72 h.

Síntomas leves: irritabilidad, insomnio, disminución del apetito, disforia, ansiedad.

Duración: 1–2 semanas.

Tratamiento: manejo conductual; rara vez requiere fármacos.

3.6. Diagnóstico diferencial

- **Delirium de otra causa (séptico, metabólico):** sin antecedente de consumo o suspensión reciente.

- **Trastornos de ansiedad primarios:** sin relación temporal con drogas.
 - **Epilepsia idiopática:** sin síntomas autonómicos previos.
 - **Síndrome serotoninérgico o neuroléptico maligno:** por fármacos psicotrópicos.
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Evaluación inicial

- **Signos vitales:** taquicardia, hipertensión, fiebre.
- **Glicemia capilar:** descartar hipoglicemia (alcoholismo).
- **Electrolitos, creatinina, función hepática.**
- **Tóxicos urinarios o plasmáticos.**
- **ECG:** arritmias (cocaína, alcohol).

4.2. Escalas clínicas

- **CIWA-Ar (Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol):** valora gravedad del SAA.
- **COWS (Clinical Opiate Withdrawal Scale):** para opiáceos.
- **SAS (Sedative-Hypnotic Withdrawal Scale):** para benzodiacepinas.

☐ Permiten ajustar dosis de medicación según severidad.

5. Tratamiento (según Guías MINSAL / Chile)

El objetivo es **aliviar los síntomas, prevenir complicaciones y facilitar la deshabitación posterior.**

5.1. Principios generales

1. **Ambiente seguro, tranquilo y supervisado.**
 2. **Hidratación y nutrición adecuadas.**
 3. **Corrección de electrolitos y vitaminas.**
 4. **Apoyo psicológico continuo.**
 5. **Monitoreo cardiovascular y neurológico.**
-

5.2. Manejo según tipo de sustancia

A. Alcohol

- **Benzodiacepinas:** diazepam o lorazepam (tituladas según CIWA).
- **Tiamina 100 mg EV antes de glucosa.**
- **Antipsicóticos (haloperidol):** solo si hay alucinaciones intensas tras control autonómico.
- **Control en UCI** si delirium tremens o convulsiones.

B. Benzodiacepinas

- **Reducción progresiva (10–20%/semana).**
- Cambiar a una de vida media larga (diazepam o clonazepam).
- **Anticonvulsivantes:** valproato o carbamazepina en casos severos.
- Evitar suspensión brusca.

C. Opiáceos

- **Buprenorfina/naloxona (Suboxone®):** primera línea (COWS $\geq$ 8).
- **Metadona:** alternativa supervisada (programas MINSAL).
- **Clonidina o lofexidina:** para síntomas vegetativos.
- **Sintomáticos:** loperamida, antieméticos, AINEs.

D. Cocaína / estimulantes

- No existe fármaco específico.
- **Benzodiazepinas:** control de agitación.
- **Antidepresivos (ISRS o bupropión):** útil en fase depresiva.
- **Psicoterapia intensiva y contención del riesgo suicida.**

E. Cannabis

- No requiere farmacoterapia.
 - **Apoyo psicológico y TCC.**
 - Si insomnio: trazodona o mirtazapina por corto plazo.
-

5.3. Continuidad del tratamiento

Una vez controlada la fase aguda:

- Derivar a **programas de rehabilitación (COSAM o SENDA).**
 - Evaluar comorbilidad psiquiátrica (trastornos del ánimo, ansiedad, psicosis).
 - Planificar estrategias de **prevención de recaídas.**
-

6. Complicaciones y pronóstico

6.1. Complicaciones

- **Convulsiones y delirium tremens (alcohol/BZD).**
- **Deshidratación y trastornos hidroelectrolíticos (opiáceos).**
- **Intento suicida (cocaína y estimulantes).**
- **Recaídas tempranas** (alto riesgo en primeros 3 meses).

6.2. Pronóstico

- **Excelente** si el síndrome se maneja adecuadamente y se logra adherencia al tratamiento.
 - **Recaídas frecuentes** si no hay seguimiento psicoterapéutico o rehabilitación.
 - Mortalidad elevada en abstinencia alcohólica no tratada (hasta 20% en DT).
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. **Tiamina antes de glucosa** en todo paciente alcohólico.
 2. **Benzodiacepinas = tratamiento de elección** en abstinencia alcohólica.
 3. **Buprenorfina/naloxona** es estándar MINSAL para opiáceos.
 4. **Nunca suspender benzodiacepinas bruscamente.**
 5. **CIWA y COWS** orientan la titulación del tratamiento.
 6. **Abstinencia a cocaína no es médica, pero sí psicológicamente riesgosa (suicidio).**
 7. **Entorno calmo y soporte constante** son parte del tratamiento.
-



Errores comunes

- Administrar glucosa antes de tiamina.
- Usar haloperidol como primera línea en abstinencia alcohólica.
- No evaluar riesgo suicida en abstinencia de estimulantes.

- Suspender benzodiacepinas de forma abrupta.
 - Tratar solo los síntomas físicos sin abordar la dependencia subyacente.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **síndrome de abstinencia** es una manifestación de **dependencia física** tras suspensión abrupta de una sustancia.
2. Los cuadros más graves y potencialmente letales son los de **alcohol y benzodiacepinas**.
3. El tratamiento se basa en **benzodiacepinas, tiamina y control sintomático**.
4. En opiáceos, la terapia de elección es **buprenorfina/naloxona o metadona**.
5. La abstinencia de cocaína y cannabis requiere **manejo psicológico y soporte emocional**.
6. **CIWA y COWS** ayudan a graduar la severidad y ajustar dosis.
7. Tras estabilización, es fundamental **derivar a programas de rehabilitación MINSAL/SENDA**.